სარეკომენდაციო ვერსია
QUET 100 მგ
აპკით შემოგარსული ტაბლეტები

გამოყენების ინსტრუქცია

QUET 100 მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტები
მიიღება პერორალურად.

აქტიური ნივთიერება: თითოეული აპკით შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს 115.13 მგ კვეტიაპინის ფუმარატს, რაც უდრის 100 მგ კვეტიაპინს.

დამხმარე ნივთიერებები: დიბაზური კალციუმის ფოსფატის დეჰიდრატი, ლაქტოზის მონოჰიდრატი (ძროხის რძისგან), პოვიდონი, ნატრიუმის სახამებლის გლიკოლატი, მაგნიუმის სტეარატი, კოლოიდური სილიციუმის დიოქსიდი, მიკროკრისტალური ცელულოზა, ნატრიუმის სტეარილის ფუმარატი, *Opadry Y-1-7000 White:* HPMC 2910/ჰიპრომელოზა 5 cp, ტიტანის დიოქსიდი, მაკროგოლი/PEG 400.

ამ მედიკამენტის მიღების დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით ინსტრუქციას, რადგან ის შეიცავს თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.
- შეინახეთ ეს ინსტრუქცია. შესაძლოა, ხელახლა დაგჭირდეთ მისი წაკითხვა.
- დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.
- ეს მედიკამენტი თქვენთვისაა დანიშნული. არ გადასცეთ ის სხვებს.
- ამ მედიკამენტის მიღებისას, ექიმთან ან საავადმყოფოში ვიზიტისას აცნობეთ ექიმს, რომ ამ მედიკამენტს იყენებთ.
- ზუსტად დაიცავით ინსტრუქციაში მითითებული წესები. არ მიიღოთ თქვენთვის რეკომენდებული დოზისგან განსხვავებული არც უფრო **მაღალი** და არც უფრო **დაბალი** დოზა.

ამ ფურცელ-ჩანართში:

1. რა არის QUET და რისთვის გამოიყენება
2. რა უნდა იცოდეთ QUET-ის მიღებამდე
3. როგორ მივიღოთ QUET
4. შესაძლო გვერდითი მოვლენები
5. როგორ შევინახოთ QUET

სათაურები ხელმისაწვდომია.

1. რა არის QUET და რისთვის გამოიყენება

QUET არის თეთრი, მრგვალი, აპკით დაფარული ტაბლეტი. QUET 100 მგ ხელმისაწვდომია 30 ტაბლეტის შეფუთვაში.
კვეტიაპინი, QUET-ის აქტიური ნივთიერება, მიეკუთვნება ანტიფსიქოტიკების (ფსიქიატრიული დაავადებების სამკურნალოდ გამოყენებული პრეპარატების) ჯგუფს.
QUET ეფექტურია შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ:
- *ბიპოლარული აშლილობის დროს გამოწვეული დიდი დეპრესიული ეპიზოდები:* როდესაც გრძნობთ სევდას. შეიძლება იგრძნოთ დეპრესია, დანაშაულის გრძნობა, ენერგიის ნაკლებობა, მადის დაკარგვა ან ძილის უუნაროობა.
- *ბიპოლარული აშლილობის დროს საშუალო და მძიმე მანიაკალური ეპიზოდები:* როდესაც შეიძლება გრძნობდეთ ძლიერ აღგზნებას, ხალისს, აგზნებადობას, ენთუზიაზმს ან

ჰიპერაქტიურობას (ჩვეულებრივზე ნაკლები ძილის საჭიროება, ჩვეულებრივზე მეტი ლაპარაკი, ფიქრების ან იდეების სწრაფი ტემპი) ან გქონდეთ ცუდი განსჯა, მათ შორის აგრესიული ან დესტრუქციული.
• მანიაკალური ან დეპრესიული ეპიზოდების რეციდივის პრევენციისთვის ბიპოლარული აშლილობის მქონე პაციენტებში, რომლებიც ადრე რეაგირებდნენ კვეტიაპინით მკურნალობაზე.
• *შიზოფრენია:* როდესაც შეიძლება გესმოდეთ ან იგრძნოთ ისეთი რამ, რაც არ არსებობს, გჯეროდეთ ისეთი რამ, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება ან იგრძნოთ უჩვეულოდ ეჭვი, შფოთვა, დაბნეულობა, დანაშაულის გრძნობა, დაძაბულობა ან დეპრესია.

ექიმმა შეიძლება გააგრძელოს QUET-ის დანიშვნა მაშინაც კი, როდესაც თავს უკეთ გრძნობთ.

2. რა უნდა იცოდეთ კვეტის მიღებამდე

QUET არ უნდა გამოიყენონ ხანდაზმულმა პაციენტებმა, რომლებსაც აღენიშნებათ ტვინის ფუნქციის დაკარგვა (დემენცია), რაც იწვევს მეხსიერებისა და აზროვნების დარღვევას. ეს იმიტომ ხდება, რომ იმ პრეპარატების ჯგუფმა, რომელსაც QUET მიეკუთვნება, შეიძლება გაზარდოს ინსულტის და ზოგიერთ შემთხვევაში, სიკვდილის რისკი დემენციის მქონე ხანდაზმულ პაციენტებში.

კვეტიაპინისა და ამ ჯგუფის სხვა პრეპარატების კლინიკურ კვლევებში, დემენციისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ხანდაზმულ პაციენტებში აღინიშნა სიკვდილის მომატებული რისკი. QUET არ არის დამტკიცებული ამ ტიპის მიღებისთვის.

ანტიდეპრესანტების გამოყენებამ, განსაკუთრებით 24 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებში, შეიძლება გაზარდოს სუიციდური აზრები ან ქცევები. ამ მიზეზით, ექიმი ყურადღებით დააკვირდება თქვენ ქცევითი ცვლილებების მოულოდნელობას, როგორიცაა მოუსვენრობა, ჰიპერაქტიურობა ან სუიციდის შესაძლებლობა, განსაკუთრებით მკურნალობის დასაწყისში და პირველ თვეებში ან დოზის გაზრდის/შემცირების ან მკურნალობის შეწყვეტის პერიოდებში. რაც შეიძლება მალე დაუკავშირდით ექიმს, თუ თქვენი მდგომარეობა გაუარესდება, თუ გაქვთ სუიციდური აზრები ან ქცევები, ან თვითდაზიანების შესახებ აზრები. QUET-ის გამოყენება არ არის რეკომენდებული 18 წლამდე ასაკის პაციენტებში.

არ მიიღოთ QUET:
• თუ გაქვთ ალერგია აქტიური ნივთიერების, კვეტიაპინის ან QUET-ის სხვა რომელიმე ინგრედიენტის მიმართ (იხილეთ „დამხმარე ნივთიერებების“ სია).
• თუ იღებთ რომელიმე შემდეგ მედიკამენტს:
- აივ ინფექციის სამკურნალო ზოგიერთი მედიკამენტი (აივ პროტეაზას ინჰიბიტორები, როგორიცაა დიდანოზინი, ლოპინავირი, რიტონავირი)
- სოკოვანი ინფექციების სამკურნალო აზოლური მედიკამენტები (კეტოკონაზოლი, ფლუკონაზოლი, იტრაკონაზოლი)
- ინფექციების სამკურნალო მედიკამენტები, როგორიცაა ერითრომიცინი ან კლარითრომიცინი
- დეპრესიის სამკურნალო ზოგიერთი მედიკამენტი, როგორიცაა ნეფაზოდონი

თუ არ ხართ დარწმუნებული, QUET-ის მიღებამდე მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ QUET-ის მიღებისას:
თუ:
• თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს გაქვთ ან გქონიათ გულის პრობლემები, მაგალითად, გულის რიტმის პრობლემები, გულის კუნთის შესუსტება ან გულის ანთება, ან თუ იღებთ რაიმე მედიკამენტს, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენი გულის ცემაზე.

• გაქვთ დაბალი არტერიული წნევა.
• გადაიტანეთ ინსულტი, განსაკუთრებით თუ ხანდაზმული ხართ.
• გაქვთ ღვიძლის პრობლემები.
• ოდესმე გქონიათ კრუნჩხვა.
• გაქვთ დიაბეტი ან გაქვთ დიაბეტის განვითარების რისკი. თუ გაქვთ, ექიმმა შეიძლება შეამოწმოს თქვენი სისხლში შაქრის დონე QUET-ის მიღების დროს.
• იცით, რომ წარსულში გქონდათ სისხლის თეთრი უჯრედების დაბალი დონე (რაც შეიძლება გამოწვეული ყოფილიყო ან არ იყოს სხვა მედიკამენტებით).
• ხართ ხანდაზმული ადამიანი დემენციით (ტვინის ფუნქციის დაკარგვა). თუ გაქვთ, QUET არ უნდა მიიღოთ, რადგან მედიკამენტების ჯგუფმა, რომელსაც QUET მიეკუთვნება, შეიძლება გაზარდოს ინსულტის რისკი, ან ზოგიერთ შემთხვევაში სიკვდილის რისკი, დემენციის მქონე ხანდაზმულ ადამიანებში. • თქვენ ხართ პარკინსონის დაავადების/პარკინსონიზმის მქონე ხანდაზმული ადამიანი.
• თქვენ ან თქვენი ოჯახის სხვა წევრს გაქვთ სისხლის შედედების ისტორია, რადგან ამ ტიპის მედიკამენტები დაკავშირებულია სისხლის შედედების წარმოქმნასთან.
• თქვენ გაქვთ ან გქონიათ მდგომარეობა, რომლის დროსაც ჩვეულებრივი ღამის ძილის დროს მოკლე პერიოდებით წყვეტთ სუნთქვას („ძილის აპნოე“) და იღებთ მედიკამენტებს, რომლებიც ანელებენ ტვინის ნორმალურ აქტივობას („დეპრესანტები“).
• გაქვთ ან გქონიათ მდგომარეობა, როდესაც შარდის ბუშტის სრულად დაცლა შეუძლებელია (შარდის შეკავება), გაქვთ გადიდებული პროსტატა, ნაწლავების ბლოკადა ან თვალშიდა წნევის მომატება. ეს მდგომარეობები ზოგჯერ გამოწვეულია მედიკამენტებით (რომლებიც „ანტიქოლინერგულ“ პრეპარატებს უწოდებენ), რომლებიც გავლენას ახდენენ ნერვული უჯრედების ფუნქციონირებაზე გარკვეული სამედიცინო მდგომარეობების სამკურნალოდ.
• გაქვთ ვენებთან დაკავშირებული პრობლემები. QUET-ი იშვიათ რისკს წარმოადგენს ვენების ოკლუზიის გამოწვევის თვალსაზრისით. თერაპიის დაწყებამდე და მის დროს უნდა გამოვლინდეს ყველა რისკ-ფაქტორი და მიღებული იქნას აუცილებელი ზომები.
• გაქვთ ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მოხმარების ისტორია.

დაუყოვნებლივ აცნობეთ ექიმს, თუ QUET-ის მიღების შემდეგ შენიშნავთ შემდეგიდან რომელიმეს:

• ცხელების, კუნთების ძლიერი შებოჭილობის, ოფლიანობის ან ცნობიერების დონის დაქვეითების კომბინაცია (ამ ფენომენს „ნეიროლეფსიური ავთვისებიანი სინდრომი“ ეწოდება). შესაძლოა საჭირო გახდეს დაუყოვნებლივი სამედიცინო დახმარება.
• უკონტროლო მოძრაობები, ძირითადად სახის ან ენის.
• თავბრუსხვევა ან ძილიანობის ძლიერი შეგრძნება. ამან შეიძლება გაზარდოს შემთხვევითი დაზიანების (დაცემის) რისკი ხანდაზმულ პაციენტებში.
• კრუნჩხვები.
• ხანგრძლივი და მტკივნეული ერექცია (პრიაპიზმი).
• გახშირებული და არარეგულარული გულისცემა, მოსვენებულ მდგომარეობაშიც კი, ასევე გულისცემის გახშირება, სუნთქვის პრობლემები, ტკივილი გულმკერდის არეში ან აუხსნელი დაღლილობა. ექიმმა უნდა შეამოწმოს თქვენი გული და საჭიროების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გადაგამისამართოთ კარდიოლოგთან.
ეს მდგომარეობები შეიძლება გამოწვეული იყოს ამ ტიპის მედიკამენტებით.

რაც შეიძლება მალე აცნობეთ ექიმს, თუ გაქვთ:

• სიცხე, გრიპის მსგავსი სიმპტომები, ყელის ტკივილი ან სხვა ინფექცია, რადგან ეს შეიძლება იყოს ლეიკოციტების ძალიან დაბალი რაოდენობის შედეგი, რამაც შეიძლება მოითხოვოს QUET-ის შეწყვეტა და/ან მკურნალობის დაწყება.
• ყაბზობა მუცლის მუდმივ ტკივილთან ერთად, ან ყაბზობა, რომელიც არ რეაგირებს მკურნალობაზე, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ნაწლავის უფრო სერიოზული ბლოკადა.
• თვითმკვლელობის ფიქრები და დეპრესიის გაუარესება
თუ დეპრესიაში ხართ, ზოგჯერ შეიძლება გაგიჩნდეთ თვითდაზიანების ან თვითმკვლელობის ფიქრები. ეს ფიქრები შეიძლება გაძლიერდეს მკურნალობის დაწყებისას, რადგან ამ მედიკამენტების მოქმედებას დრო სჭირდება, ჩვეულებრივ, დაახლოებით 2 კვირა, მაგრამ ზოგჯერ უფრო მეტი. ეს ფიქრები ასევე შეიძლება გაძლიერდეს, თუ მოულოდნელად შეწყვეტთ მედიკამენტების მიღებას. შესაძლოა, უფრო მეტად გქონდეთ მსგავსი ფიქრები, თუ ახალგაზრდა ზრდასრული ხართ. კლინიკური კვლევებიდან მიღებული ინფორმაცია აჩვენებს სუიციდური ფიქრების და/ან სუიციდური ქცევის მომატებულ რისკს 25 წლამდე ასაკის დეპრესიის მქონე ახალგაზრდებში.
თუ ნებისმიერ დროს გაგიჩნდებათ თვითდაზიანების ან თვითმკვლელობის ფიქრები, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ექიმს ან მიმართეთ საავადმყოფოს. შესაძლოა, თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს ნათესავისთვის ან ახლო მეგობრისთვის დეპრესიის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ამ ბროშურის წაკითხვა. შეგიძლიათ სთხოვოთ, გითხრან, ფიქრობენ თუ არა, რომ თქვენი დეპრესია გაუარესდება ან აწუხებთ თუ არა თქვენი ქცევის ცვლილებები.

კანის მძიმე გვერდითი რეაქციები (SCARs)
ამ მედიკამენტით მკურნალობისას ძალიან იშვიათად აღინიშნა კანის მძიმე გვერდითი რეაქციები (SCARs), რომლებიც შეიძლება იყოს სიცოცხლისთვის საშიში ან ფატალური. ისინი ხშირად ვლინდება შემდეგი სიმპტომებით:
• სტივენს-ჯონსონის სინდრომი (SJS) – გავრცელებული გამონაყარი ბუშტუკებით და აქერცლილი კანით, განსაკუთრებით პირის ღრუს, ცხვირის, თვალების და სასქესო ორგანოების გარშემო
• ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი (TEN) – უფრო მძიმე ფორმა, რომელიც იწვევს კანის ძლიერ აქერცვლას
• წამლისმიერი რეაქცია ეოზინოფილიით და სისტემური სიმპტომებით (DRESS) – მოიცავს გრიპის მსგავს სიმპტომებს, რომლებიც შერწყმულია გამონაყართან, ცხელებასთან, გადიდებულ ჯირკვლებთან და სისხლის ანალიზის პათოლოგიურ შედეგებთან (მათ შორის სისხლის თეთრი უჯრედების დონის მატება (ეოზინოფილია) და ღვიძლის ფერმენტების დონის მატება)
• მწვავე გენერალიზებული ეგზანთემატოზური პუსტულოზი (AGEP) – პატარა ჩირქით სავსე ბუშტუკები
მულტიფორმული ერითემა (EM) – კანზე გამონაყარი არარეგულარული, წითელი და ქავილი ლაქებით
დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ QUET-ის გამოყენება, თუ განვითარდება რომელიმე ეს სიმპტომი და აცნობეთ ექიმს ან დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას

წონის მატება
QUET-ის მიმღებ პაციენტებში დაფიქსირდა წონის მატება. ექიმთან რეგულარულად უნდა აკონტროლოთ თქვენი წონა.

ბავშვები და მოზარდები
QUET არ არის განკუთვნილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და მოზარდებისთვის.

თუ ეს გაფრთხილებები თქვენ გეხებათ, თუნდაც წარსულში, მიმართეთ ექიმს.

QUET-ის მიღება საკვებთან და სასმელთან ერთად
QUET-ის მიღება შესაძლებელია საკვებთან ერთად ან მის გარეშე.
ფრთხილად იყავით ალკოჰოლის რაოდენობასთან დაკავშირებით. ეს იმიტომ ხდება, რომ QUET-ისა და ალკოჰოლის კომბინირებულმა ეფექტმა შეიძლება გამოიწვიოს ძილიანობა.

QUET-ით მკურნალობის დროს არ დალიოთ გრეიფრუტის წვენი. გრეიფრუტის წვენმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს პრეპარატის მოქმედებაზე.

ორსულობა
ამ პრეპარატის მიღებამდე გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან ან ფარმაცევტთან.

თუ ფიქრობთ, რომ ორსულად ხართ ან გეგმავთ ორსულობას, QUET-ის მიღებამდე აცნობეთ ექიმს. ორსულობის დროს QUET არ უნდა მიიღოთ, თუ ეს არ არის განხილული თქვენს ექიმთან.
ორსულობის ბოლო 3 თვის განმავლობაში ანტიფსიქოზური მედიკამენტების (ეფექტურია ფსიქიკური დაავადებების, როგორიცაა შიზოფრენია, ფსიქოზური დეპრესია) მიღებისას დედების ახალშობილებს აქვთ კუნთების პათოლოგიური მოძრაობების და/ან წამლის მოხსნის სიმპტომების განვითარების რისკი, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს სიმძიმის მიხედვით დაბადების შემდეგ. ეს სიმპტომები მოიცავს მოუსვენრობას, კუნთების ჭარბ დაჭიმულობას, კუნთების დაჭიმულობის დაკარგვას, კანკალს, ძილიანობას, სუნთქვის გაძნელებას ან კვების დარღვევებს. თუ თქვენს პატარას განუვითარდება რომელიმე ეს სიმპტომი, აუცილებლად დაუკავშირდით ექიმს.

თუ მკურნალობის დროს გაიგებთ, რომ ორსულად ხართ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ძუძუთი კვება
ამ პრეპარატის მიღებამდე გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან ან ფარმაცევტთან.
ამ პრეპარატის გამოყენებისას არ მისცეთ ბავშვს ძუძუთი კვება.

მანქანის მართვა და მექანიზმებთან მუშაობა
ამ პრეპარატის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ძილიანობა. არ მართოთ ავტომობილი და მექანიზმებთან მუშაობა, სანამ არ გაიგებთ, თუ როგორ მოქმედებს მედიკამენტი თქვენზე.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია QUET-ის ზოგიერთი დამხმარე ნივთიერების შესახებ
QUET შეიცავს ლაქტოზას, რომელიც შაქრის ერთ-ერთი სახეობაა. თუ ექიმმა გითხრათ, რომ ვერ იტანთ ზოგიერთ შაქარს, ამ მედიკამენტის მიღებამდე მიმართეთ ექიმს.

სხვა მედიკამენტების მიღება
არ მიიღოთ QUET, თუ იღებთ რომელიმე შემდეგ მედიკამენტს:
• ზოგიერთი მედიკამენტი, რომელიც გამოიყენება შიდსის (აივ) სამკურნალოდ (მაგალითად, აივ-პროტეაზას ინჰიბიტორები, მაგ. დიდანოზინი, ლოპინავირი, რიტონავირი)
• აზოლის კლასის მედიკამენტები, რომლებიც გამოიყენება სოკოვანი ინფექციების სამკურნალოდ (მაგალითად, კეტოკონაზოლი, ფლუკონაზოლი, იტრაკონაზოლი)
• ერითრომიცინი ან კლარითრომიცინი (გამოიყენება ინფექციების სამკურნალოდ)

• დეპრესიის სამკურნალო მედიკამენტები, მაგ. ნეფაზოდონი

აცნობეთ ექიმს, თუ იღებთ რომელიმე შემდეგ მედიკამენტს:
• ეპილეფსიის სამკურნალო მედიკამენტები (მაგალითად, ფენიტოინი ან კარბამაზეპინი)
• მაღალი არტერიული წნევის სამკურნალო მედიკამენტები
• ბარბიტურატები (ძილის გაძნელების სამკურნალოდ)
• თიორიდაზინი ან ლითიუმი (სხვა ანტიფსიქოზური მედიკამენტები)
• მედიკამენტები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გულისცემაზე, მაგალითად, მედიკამენტები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ ელექტროლიტების დისბალანსი (კალიუმის ან მაგნიუმის დაბალი დონე), როგორიცაა შარდმდენები (შარდმდენი აბები) ან გარკვეული ანტიბიოტიკები (ინფექციების სამკურნალოდ გამოყენებული მედიკამენტები)
• მედიკამენტები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ ყაბზობა
• მედიკამენტები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ნერვული უჯრედების ფუნქციაზე გარკვეული სამედიცინო მდგომარეობების სამკურნალოდ (ე.წ. „ანტიქოლინერგები“)

რომელიმე მედიკამენტის მიღების შეწყვეტამდე, გთხოვთ, მიმართოთ ექიმს.

თუ ამჟამად იღებთ ან ბოლო დროს იღებდით რეცეპტით ან ურეცეპტოდ გაცემულ მედიკამენტებს, გთხოვთ, აცნობოთ ექიმს ან ფარმაცევტს ასეთი მედიკამენტების შესახებ.

შარდის ნარკოტიკების სკრინინგზე გავლენა
თუ შარდის ნარკოტიკების სკრინინგს იტარებთ, QUET-ის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს დადებითი შედეგები მეტადონზე ან დეპრესიის სამკურნალო გარკვეულ პრეპარატებზე, რომლებსაც ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები (TCA) ეწოდება, როდესაც გამოიყენება ზოგიერთი ტესტის მეთოდი, მაშინაც კი, თუ შეიძლება არ იღებთ მეტადონს ან TCA-ებს. თუ ასეთი შედეგი მიიღება, შედეგები შეიძლება დადასტურდეს უფრო სპეციფიკური ტესტებით.

3. როგორ მივიღოთ QUET
ინსტრუქციები სათანადო გამოყენებისა და დოზის/მიღების სიხშირის შესახებ
ყოველთვის მიიღეთ QUET ზუსტად ისე, როგორც ექიმმა დაგინიშნათ. თუ არ ხართ დარწმუნებული, უნდა მიმართოთ ექიმს ან ფარმაცევტს.
ექიმი გადაწყვეტს თქვენს საწყის დოზას. შემანარჩუნებელი დოზა (დღიური დოზა) დამოკიდებული იქნება თქვენს დაავადებასა და საჭიროებებზე, მაგრამ ჩვეულებრივ იქნება 150 მგ-დან 800 მგ-მდე.

მიღების წესი და გზა
• ტაბლეტებს მიიღებთ დღეში ერთხელ, ძილის წინ ან დღეში ორჯერ, თქვენი დაავადების მიხედვით.
• ტაბლეტები გადაყლაპეთ მთლიანად წყალთან ერთად.
• ტაბლეტების მიღება შეგიძლიათ საკვებთან ერთად ან მის გარეშე.
• QUET-ის მიღების დროს არ დალიოთ გრეიფრუტის წვენი. ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს პრეპარატის მოქმედებაზე.

• არ შეწყვიტოთ ტაბლეტების მიღება, თუნდაც თავს უკეთ გრძნობდეთ, თუ ექიმი სხვაგვარად არ გეტყვით.

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები

• გამოყენება ბავშვებსა და მოზარდებში

QUET არ უნდა გამოიყენონ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა და მოზარდებმა.

• გამოყენება ხანდაზმულებში

თუ ხანდაზმული ხართ, ექიმმა შეიძლება შეცვალოს თქვენი დოზა.

გამოყენების განსაკუთრებული პირობები

• თირკმლის პრობლემები

დოზის კორექცია საჭირო არ არის თირკმლის პრობლემების მქონე პაციენტებისთვის.

• ღვიძლის პრობლემები

თუ გაქვთ ღვიძლის პრობლემები, ექიმმა შეიძლება შეცვალოს თქვენი დოზა.

თუ შეამჩნევთ, რომ QUET-ის ეფექტი ძალიან ძლიერი ან ძალიან სუსტია, მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

თუ მიიღეთ QUET-ის საჭიროზე მეტი დოზა

თუ მიიღეთ QUET-ის საჭიროზე მეტი დოზა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

თუ მიიღეთ QUET-ის საჭიროზე მეტი დოზა, შეიძლება იგრძნოთ ძილიანობა, თავბრუსხვევა და გულისცემის დარღვევა. დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ექიმს ან უახლოეს საავადმყოფოს. თან იქონიეთ QUET-ის ტაბლეტები.

თუ დაგავიწყდათ QUET-ის მიღება

არ მიიღოთ ორმაგი დოზა გამოტოვებული დოზის ასანაზღაურებლად.

თუ დაგავიწყდათ დოზის მიღება, მიიღეთ ის როგორც კი გაგახსენდებათ. თუ ახლოვდება შემდეგი დოზის მიღების დრო, დაელოდეთ მანამ.

თუ შეწყვეტთ QUET-ის მიღებას

თუ მოულოდნელად შეწყვეტთ QUET-ის მიღებას, შეიძლება ვერ დაიძინოთ (უძილობა), ან თავი ცუდად იგრძნოთ (გულისრევა), ან შეიძლება განიცადოთ თავის ტკივილი, დიარეა, ღებინება, თავბრუსხვევა ან გაღიზიანება. ექიმმა შეიძლება გირჩიოთ დოზის თანდათანობით შემცირება მკურნალობის შეწყვეტამდე.

თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი კითხვები ამ პრეპარატის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

4. შესაძლო გვერდითი მოვლენები

ყველა მედიკამენტის მსგავსად, ამ მედიკამენტმაც შეიძლება გამოიწვიოს გვერდითი მოვლენები, თუმცა ისინი ყველას არ უვითარდება.

თუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე გამოვლინდა, შეწყვიტეთ QUET-ის გამოყენება და დაუყოვნებლივ აცნობეთ ექიმს ან მიმართეთ უახლოეს გადაუდებელი დახმარების განყოფილებას:

• მძიმე ალერგიული რეაქცია, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის გაძნელება ან შოკი (ანაფილაქსია)

• ალერგიული რეაქციები, მათ შორის კანის ბუშტუკები, კანის შეშუპება და პირის ღრუს გარშემო შეშუპება
• კანის სწრაფი შეშუპება, ჩვეულებრივ თვალების, ტუჩების და ყელის გარშემო (ანგიონევროზული შეშუპება)
ეს ყველა ძალიან სერიოზული გვერდითი მოვლენაა. თუ რომელიმე მათგანი გამოვლინდა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ სერიოზული ალერგია QUET-ზე. შეიძლება დაგჭირდეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ან ჰოსპიტალიზაცია. ეს გვერდითი მოვლენები იშვიათად გვხვდება.

გვერდითი მოვლენები კლასიფიცირდება შემდეგი სიხშირით:
ძალიან ხშირი: შეიძლება აღენიშნებოდეს 10 პაციენტიდან სულ მცირე 1-ს.
ხშირი: შეიძლება აღენიშნებოდეს 10 პაციენტიდან 1-ზე ნაკლებს, მაგრამ 100 პაციენტიდან 1-ზე მეტს.
არახშირი: შეიძლება აღენიშნებოდეს 100 პაციენტიდან 1-ზე ნაკლებს, მაგრამ 1000 პაციენტიდან 1-ზე მეტს.
იშვიათი: შეიძლება აღენიშნებოდეს 1000 პაციენტიდან 1-ზე ნაკლებს, მაგრამ 10000 პაციენტიდან 1-ზე მეტს.
ძალიან იშვიათი: შეიძლება აღენიშნებოდეს 10000 პაციენტიდან 1-ზე ნაკლებს.
უცნობია: არსებული მონაცემებით შეფასება შეუძლებელია.

QUET-ის სხვა გვერდითი მოვლენებია:

ძალიან ხშირი
• თავბრუსხვევა (შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა), თავის ტკივილი, პირის სიმშრალე.
• ჰემოგლობინის დონის შემცირება
• ძილიანობის შეგრძნება (ეს შეიძლება დროთა განმავლობაში გაქრეს, QUET-ის მიღების გაგრძელებისას) (შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა).
• შეწყვეტის სიმპტომები (სიმპტომები, რომლებიც ვლინდება QUET-ის მიღების შეწყვეტისას) მოიცავს ძილის უკმარისობას (უძილობა), გულისრევის შეგრძნებას (ღებინება), თავის ტკივილს, დიარეას, გულისრევას (ღებინებას), თავბრუსხვევას და გაღიზიანებას. რეკომენდებულია თანდათანობითი შეწყვეტა მინიმუმ 1-2 კვირის განმავლობაში.
• წონაში მატება.
• კუნთების პათოლოგიური მოძრაობები. ეს მოიცავს კუნთების მოძრაობების დაწყების სირთულეს, კანკალს, მოუსვენრობას ან კუნთების შებოჭილობას ტკივილის გარეშე.
• გარკვეული ცხიმების (ტრიგლიცერიდების და საერთო ქოლესტერინის) რაოდენობის ცვლილებებს.

ხშირი
• გულისცემის აჩქარება.
• გულისცემის გახშირება, აჩქარება ან გამოტოვებული დარტყმების შეგრძნება.
• ყაბზობა, კუჭის აშლილობა (მონელების დარღვევა).
• სისუსტის შეგრძნება.
• ხელების ან ფეხების შეშუპება.
• დაბალი არტერიული წნევა ადგომისას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუსხვევა ან სისუსტის შეგრძნება (შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა).
• სისხლში შაქრის დონის მომატება.
• მხედველობის დაბინდვა.

• უჩვეულო სიზმრები და კოშმარები.
• შიმშილის გრძნობა.
• გაღიზიანების შეგრძნება.
• მეტყველებისა და ენის დარღვევა.
• თვითმკვლელობის ფიქრები და დეპრესიის გაუარესება.
• ქოშინი.
• ღებინება (ძირითადად ხანდაზმულებში).
• ცხელება.
• სისხლში ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების რაოდენობის ცვლილებები.
• სისხლის გარკვეული ტიპის უჯრედების რაოდენობის შემცირება.
• სისხლში ღვიძლის ფერმენტების რაოდენობის ზრდა.
• სისხლში პროლაქტინის ჰორმონის რაოდენობის ზრდა. იშვიათ შემთხვევებში, პროლაქტინის ჰორმონის მომატებამ შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგი:

- მამაკაცებსა და ქალებში მკერდის შეშუპება და დედის რძის მოულოდნელი გამომუშავება.
- ქალებში მენსტრუაციის არარსებობა ან არარეგულარული მენსტრუაცია.

არახშირი
• კრუნჩხვები ან კრუნჩხვები.
• ალერგიული რეაქციები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს ამობურცულ კვანძებს (ბუშტუკებს), კანის შეშუპებას და პირის ირგვლივ შეშუპებას.
• უსიამოვნო შეგრძნებები ფეხებში (ასევე ცნობილია, როგორც მოუსვენარი ფეხების სინდრომი).
• ყლაპვის გაძნელება.
• უკონტროლო მოძრაობები, ძირითადად სახის ან ენის.
• სექსუალური დისფუნქცია.
• დიაბეტი.
• გულის ელექტრული აქტივობის ცვლილება, რომელიც ჩანს ეკგ-ზე (QT ინტერვალის გახანგრძლივება).
• გულისცემის ნორმაზე შენელება, რომელიც შეიძლება განვითარდეს მკურნალობის დაწყებისას და რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს დაბალ არტერიულ წნევასთან და გონების დაკარგვასთან.
• შარდვის გაძნელება.
• გონების დაკარგვა (შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა).
• ცხვირის გაჭედვა.
• სისხლის წითელი უჯრედების რაოდენობის შემცირება.
• სისხლში ნატრიუმის რაოდენობის შემცირება.
• ნეიტროფილების, სისხლის თეთრი უჯრედების ერთ-ერთი სახეობის, რაოდენობის შემცირება.
• უკვე არსებული დიაბეტის გაუარესება.
კონფუზიური მდგომარეობა.
• თრომბოციტების (სისხლის თრომბოციტების) რაოდენობის შემცირება.
• სისხლში ჰორმონების დონის შემცირება (თავისუფალი T3-ის შემცირება, ჰიპოთირეოზი).
• შრატის ასპარტატ ამინოტრანსფერაზას (AST) დონის მომატება (ფერმენტული ტესტი, რომელიც ხშირად გამოიყენება გულისა და ღვიძლის დაავადებების დიაგნოსტიკისთვის).

იშვიათი

• მაღალი ტემპერატურის (ცხელება), ოფლიანობის, კუნთების დაჭიმულობის, ძლიერი ძილიანობის ან სისუსტის შეგრძნების კომბინაცია (დარღვევა, რომელსაც „ნეიროლეფსიური ავთვისებიანი სინდრომი“ ეწოდება).
• კანისა და თვალების გაყვითლება (სიყვითლე).
• ღვიძლის ანთება (ჰეპატიტი).
• ხანგრძლივი და მტკივნეული ერექცია (პრიაპიზმი).
• სარძევე ჯირკვლების შეშუპება და დედის რძის მოულოდნელი გამოყოფა (გალაქტორეა).
• მენსტრუალური ციკლის დარღვევა.
• სისხლის კოლტები ვენებში, განსაკუთრებით ფეხებში (სიმპტომებია შეშუპება, ტკივილი და სიწითლე ფეხში), რომლებიც შეიძლება სისხლძარღვების მეშვეობით ფილტვებში გადავიდეს და გამოიწვიოს გულმკერდის ტკივილი და სუნთქვის გაძნელება. თუ შეამჩნევთ რომელიმე ამ სიმპტომს, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.
• სიარული, საუბარი, ჭამა ან სხვა აქტივობები ძილის დროს.
• სხეულის ტემპერატურის დაქვეითება (ჰიპოთერმია).
• პანკრეასის ანთება.
• მდგომარეობა (ე.წ. „მეტაბოლური სინდრომი“), რომლის დროსაც შეიძლება გქონდეთ შემდეგი სიმპტომებიდან 3 ან მეტის კომბინაცია: მუცლის გარშემო ცხიმის მომატება, „კარგი ქოლესტერინის“ (HDL-C) შემცირება, სისხლში ცხიმის ისეთი სახეობის მომატება, როგორიცაა ტრიგლიცერიდები, მაღალი არტერიული წნევა და სისხლში შაქრის დონის მომატება.
• ცხელების, გრიპის მსგავსი სიმპტომების, ყელის ტკივილის ან სხვა ნებისმიერი ინფექციის კომბინაცია სისხლის თეთრი უჯრედების ძალიან დაბალ რაოდენობასთან ერთად, მდგომარეობა, რომელსაც აგრანულოციტოზი ეწოდება.
• ნაწლავის ობსტრუქცია.
• სისხლში კრეატინ ფოსფოკინაზას (კუნთებიდან მიღებული ნივთიერება) მომატება.
• სუნთქვის ხანმოკლე შეფერხება ნორმალური ღამის ძილის დროს (ძილის აპნოე).

ძალიან იშვიათი
• ძლიერი გამონაყარი, ბუშტუკები ან კანზე წითელი ლაქები.
• მძიმე ალერგიული რეაქცია (ანაფილაქსია), რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის გაძნელება ან შოკი.
• კანის სწრაფი შეშუპება, ჩვეულებრივ თვალების, ტუჩების და ყელის ირგვლივ (ანგიონევროზული შეშუპება).
• კანის, პირის ღრუს, თვალების და სასქესო ორგანოების სერიოზული ბუშტუკოვანი მდგომარეობა (სტივენს-ჯონსონის სინდრომი).
• შარდის მოცულობის მარეგულირებელი ჰორმონის არასაკმარისი სეკრეცია.
• კუნთოვანი ბოჭკოების დაშლა და ტკივილი კუნთებში (რაბდომიოლიზი).

უცნობია
• კანზე გამონაყარი არარეგულარული წითელი ლაქებით (ერითემა მულტიფორმული).
• კანის წითელი უბნების სწრაფი გაჩენა პატარა პუსტულებით (თეთრი/ყვითელი სითხით სავსე პატარა ბუშტუკები, რომელსაც მწვავე გენერალიზებული ეგზანთემატოზური პუსტულოზი (AGEP) ეწოდება).
• სერიოზული, უეცარი ალერგიული რეაქცია ისეთი სიმპტომებით, როგორიცაა ცხელება და ბუშტუკები კანზე და კანის აქერცვლა (ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი).
• ეოზინოფილიითა და სისტემური სიმპტომებით მიმდინარე წამლისმიერი რეაქცია (DRESS) მოიცავს გრიპის მსგავს სიმპტომებს, რომლებიც ვლინდება გამონაყარით, ცხელებით,

ჯირკვლების შეშუპებით და სისხლის ანალიზის პათოლოგიური შედეგებით (მათ შორის ლეიკოციტების (ეოზინოფილია) და ღვიძლის ფერმენტების მომატებით).
• მოხსნის სინდრომის სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს ახალშობილებში, რომელთა დედები ორსულობის დროს იყენებდნენ კვეტიაპინს.
• ინსულტი.
• გულის კუნთის დარღვევა (კარდიომიოპათია).
• გულის კუნთის ანთება (მიოკარდიტი).
• სისხლძარღვების ანთება (ვასკულიტი), ხშირად კანზე გამონაყარით პატარა წითელი ან იისფერი ამობურცულობებით.

მედიკამენტების კლასს, რომელსაც QUET მიეკუთვნება, შეუძლია გულის რიტმის პრობლემების გამოწვევა, რაც შეიძლება სერიოზული იყოს და მძიმე შემთხვევებში შეიძლება ფატალურიც კი იყოს.

ზოგიერთი გვერდითი მოვლენა მხოლოდ სისხლის ანალიზის ჩატარებისას შეინიშნება. ესენია: სისხლში გარკვეული ცხიმების (ტრიგლიცერიდების და საერთო ქოლესტერინის) ან შაქრის რაოდენობის ცვლილებები, სისხლში ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების რაოდენობის ცვლილებები, ღვიძლის ფერმენტების მომატება, სისხლის გარკვეული ტიპის უჯრედების რაოდენობის შემცირება, სისხლის წითელი უჯრედების რაოდენობის შემცირება, სისხლში კრეატინფოსფოკინაზას (კუნთებში არსებული ნივთიერება) მომატება, სისხლში ნატრიუმის რაოდენობის შემცირება და სისხლში ჰორმონ პროლაქტინის რაოდენობის ზრდა. ჰორმონ პროლაქტინის მომატებამ იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგი:
• მამაკაცებსა და ქალებში სარძევე ჯირკვლების შეშუპება და დედის რძის მოულოდნელი გამოყოფა
• ქალებში მენსტრუაციის არარსებობა ან არარეგულარული მენსტრუაცია

დამატებითი გვერდითი მოვლენები ბავშვებსა და მოზარდებში
იგივე გვერდითი მოვლენები, რომლებიც შეიძლება გამოვლინდეს მოზრდილებში, შეიძლება ასევე გამოვლინდეს ბავშვებსა და მოზარდებში.
შემდეგი გვერდითი მოვლენები უფრო ხშირად აღინიშნა ბავშვებსა და მოზარდებში ან არ აღინიშნა მოზრდილებში:

ძალიან ხშირი
• სისხლში პროლაქტინის ჰორმონის რაოდენობის მომატება. ჰორმონ პროლაქტინის მომატებამ იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგი:
- ბიჭებსა და გოგონებში მკერდის შეშუპება და დედის რძის მოულოდნელად გამოყოფა.
- გოგონებში მენსტრუაციის არარსებობა ან არარეგულარული მენსტრუაცია.

• მადის მომატება.
• ღებინება.
• კუნთების პათოლოგიური მოძრაობები. ესენია კუნთების მოძრაობების დაწყების გაძნელება, კანკალი, მოუსვენრობის შეგრძნება ან კუნთების შებოჭილობა ტკივილის გარეშე.
• არტერიული წნევის მომატება.

ხშირი
• სისუსტის შეგრძნება, გონების დაკარგვა (შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა).
• ცხვირის გაჭედვა.

• გაღიზიანების შეგრძნება.

გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინება
თუ თქვენ შეამჩნევთ რაიმე გვერდით მოვლენას, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ისინი მითითებული გამოყენების ინსტრუქციაში, მიმართეთ ექიმს, ფარმაცევტს ან ექთანს. ასევე შეგიძლიათ შეატყობინოთ ნებისმიერი გვერდითი მოვლენის შესახებ თურქეთის ფარმაკოზედამხედველობის ცენტრს (TÜFAM) ვებგვერდზე www.titck.gov.tr-ზე „წამლის გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინების“ ხატულაზე დაწკაპუნებით ან გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინების ცხელ ხაზზე დარეკვით ნომერზე 0800 314 00 08. გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინებით, თქვენ ხელს შეუწყობთ თქვენს მიერ გამოყენებული პრეპარატის უსაფრთხოების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღებას.

თუ შეამჩნევთ რაიმე გვერდით მოვლენას, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი ამ ინსტრუქციაში, გთხოვთ, აცნობოთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

5. როგორ შევინახოთ QUET

შეინახეთ QUET ბავშვებისთვის მიუწვდომელ და უხილავ ადგილას, ორიგინალ შეფუთვაში.
შეინახეთ QUET 25°C-ზე დაბალ ოთახის ტემპერატურაზე.
მიიღეთ ეს წამალი ვარგისიანობის ვადის შესაბამისად.
არ გამოიყენოთ QUET შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.

არ გადაყაროთ წამლები ჩამდინარე წყლებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში. ჰკითხეთ ფარმაცევტს, თუ როგორ გადაყაროთ გამოუყენებელი წამლები. ეს ზომები ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას.

გაცემის წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით

ლიცენზიის მფლობელი:
Deva Holding A.Ş.
Küçükçekmece / ISTANBUL
ტელ: 0 212 692 92 92
ფაქსი: 0 212 697 00 24
ელ. ფოსტა: deva@devaholding.com.tr

წარმოების ადგილი:
Deva Holding A.Ş.
Kapaklı/TEKİRDAG

ეს ინსტრუქცია ბოლოს დამტკიცდა 21/09/2023-ში.